

--

Name: فاطمه اسماعيل احمد عثمان National ID: 25210122700681	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Bilateral mammogram and breast ultrasound
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



فاطمه

اسماعيل احمد عثمان اسماعيل

١ ش حسن الحداد

مركز أوسيم - الجيزة

١٩٥٢/١ ٧٨٢

٢٥٢١٠ ١٢ ٢٧ ٠٠٦ ٨١

KU8051347



٢٠٢٤/١٠ ٢٥٢١٠١٢٢٧٠٠٦٨١

ربة منزل

أرملة

مسلمة

أنثى



البطاقة سارية حتى ٢٠٣١/١٠/١٨

١



Name: فاطمة اسماعيل احمد عثمان		
MR. : 6219		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالتها		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها The patient presents with a right breast carcinoma classified as T1c N1, invasive ductal carcinoma, estrogen receptor 8/8, progesterone receptor 7/8, HER2 2+ amplified. The tumor was managed with a mastectomy and axillary dissection. Adjuvant chemotherapy consisted of 12 cycles of taxol and 17 cycles of trastuzumab (herceptin). Post-operative radiation therapy was administered to the chest wall and regional nodes. The patient has been receiving aromatase inhibitor therapy (Femara) since February 2023, with ongoing support for three months. The patient has completed 12 cycles of taxol and 17 cycles of herceptin.		
تحريرا في ,		
	التاريخ :	19-09-2026
	الوقت :	
	Reham Ahmed Fathy Ibrahim	الطبيب المعالج :
يعتمد ,		

Patient Name : الأستاذة / فاطمة اسماعيل احمد عثمان اسماعيل	Request No. : 13001840
Patient No. : 25210122700881	Request Date : 28/08/2022
Path No. : 2525/22	Verification Date : 28/09/2022
Sex : Female	Financial Category : نفقة التولية - أورام دار السلام
Age : 69 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Right breast mass lesion

Nature of the specimen:

Tru cut biopsy collected 28-8-2022 (10 :40 AM)

Gross Examination:

Fragmented greyish white tissue cores ranging from 0.2 to 0.7 cm . Totally submitted .

IHC technique: Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench

Mark ULTRA system for ER, PR,HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

- * Histological type: Invasive duct carcinoma
- * Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1)
- * Ductal carcinoma in situ: No
- * IPT (Positive control showed appropriate reactivity) :
- * ER: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (Allred score 8/8)
- * PR: Moderate nuclear reaction in 60% of tumor cells (Allred score 6/8)
- * HER2: Weak incomplete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 2+)
- * Ki 67: 20% nuclear reaction of tumor cells
- * Average Her2 copy No : 5
- * Her2/CEP17 ratio : 2.2
- * SISH : Amplified

Diagnosis:

Right breast mass lesion , Tru cut biopsy:

Invasive duct carcinoma grade II ✓

- * ER: Positive (score 8/8).
- * PR: Positive (score 6/8).
- * HER2: Equivocal (score 2+).
- * Ki67: Positive in 20% of tumor cells.

Verified by :

DR.Israa Elgendy



Printing Date : 28/09/2022 10:33:06

Page 1 of 2

Printing By : marwa mohamed youss

Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab
المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي

Patient Name : الأستاذة / فاطمة اسماعيل احمد عثمان اسماعيل	Request No. : 13008849
Patient No. : 25210122700681	Request Date : 29/08/2022
Path No. : 2525/22	Verification Date : 28/09/2022
Sex : Female	Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age : 69 Y	Department : Out Patient
Referreing Doc :	Registered by : .marwa mohamed youss

Pathology Report

* SISH : Amplified

Prof.Dr.Gamal Abdelatty

Dr.Israa Elgendy

Verified by :
DR.Israa Elgendy

Printing Date : 28/09/2022 10:33:06

Page 2 of 2

Printing By : .marwa mohamed youss

Patient Name : الأمستاده / فاطمة اسماعيل سميدشمان اسماعيل
 Patient No. : 25210122700681
 Path No. : 3008/22
 Sex : Female
 Age : 69 Y
 Referring Doc :
 Request No. : 1000-779
 Request Date : 25/10/2022
 Verification Date : 25/10/2022
 Financial Category : نقطة الدولة - اوتوPatient
 Department : Out Patient
 Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data : Right breast cancer

Nature of the specimen : Right MRM

Gross Examination:

- Procedure: Right MRM specimen measured 19x18x4 cm , covering skin ellipse measured 15x9 cm .
- Tumor extent : An ill defined greyish white firm mass measured 0.6x0.6 cm .
- Distance from margins: 2 cm away from deep margin .
- Lymph nodes number and size: A fibrofatty tissue piece measured 7x5x2 cm enclosing 9 SLNs up to 1.5 cm .

Microscopic examination:

- Histological type: Invasive duct carcinoma
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1)
- Angioinvasion: Occasional
- Perineural invasion : No
- Ductal carcinoma in situ: Present 5%
- Lymph node involvement: Positive (1/9) without extracapsular extension .
- Resection Margins: Free margins
- Additional pathologic findings: Rest of breast showing mammary ductectasia, florid atypical ductal hyperplasia , apocrine metaplasia .

Diagnosis:

Right MRM :

Invasive duct carcinoma Grade II with DCIS .

- Positive LNs (1/9) without extracapsular extension .
- Free skin , free margins
- Occasional lymphovascular emboli .
- Stage : pT1b , pN1

Prof. Dr. Lubna Omar

Verified by :

saamah sayed

Printing Date : 25/10/2022 10:03:35

Page 1 of 2

Printing By : Ali mostafa



Presidential Program for Women's health

Name: Fatma Ismaeel Ahmed

Date: 24/9/2022

Targeted Bilateral axillary Ultrasound

Clinical summary: right breast pathologically proved IDC

Technique

High resolution ultrasound with Color Doppler.

Detailed Findings

Right breast

- Second look ultrasound showed multicentric malignant looking variable size mass lesions scattered at area between 11-12 o'clock till 1-2 o'clock the largest seen at 11 o'clock measuring 13.3x9mm and the rest (about 3 lesions) are ranging from 8mm to 4mm with suggesting intraductal extension.
- One pathological axillary lymph node measuring 17mm with focal thickened cortex reaching 4.7 mm with eccentric hilum at Level I

Left breast

- No solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- Axillary non-specific nodes.

Conclusion:

Right breast (BIRADS 6) multicentric IDC, with pathological axillary lymph nodes at Level I

Left breast (BIRADS 1)

DR. shaden Mahmoud

Patient Name: Fatma Ismail Ahmed Othman Ismail	Date : 30/08/2025
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 73 Year(s)
Medical ID: 3705/2022	Pat. ID: 20899

**LEFT BREAST MAMMOGRAPHY WITH BILATERAL
ULTRASOUND**

INDICATION:

- Right MRM

TECHNIQUE:

- Left breast MLO and CC views
- Bilateral ultrasound

REPORT:

- Fairly dense parenchyma, (ACR B).
- No dominant mass is seen, yet complementary U/S also showed a small iso-hypoechoic solid nodule located at 11 o'clock, measuring 8x4mm. Colour Doppler depicted no abnormal flow.
- Few benign calcifications are also noted.
- Normal skin thickness and nipple-areola complex.
- Left nonspecific axillary nodes, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free right operative bed with no evidence of recurrent mass lesions, and free infra and supra clavicular regions.

OPINION:

- Right MRM with free operative bed.
- Left small UIQ benign looking lesion, likely a fibroadenoma, (BIRADS 3).

Best regards,
Dr. Mahi Mokhtar



Patient Name: Fatma Ismail Ahmed Othman Ismail	Date : 23/05/2024
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 71 Year(s)
Medical ID: 3705/2022	Pat. ID: 20899

Targeted ultrasound on right operative bed

Indication:

- Patient with right MRM with palpable operative bed lesion for assessment.

Report:

- The area of patient complain is consistent to post-operative fibrosis, with no suspicious findings detected (BIRADS 2)
- Free supra and infra clavicular regions.

Signature Dr. Engy Abdallah

23/05/2024 5:10 PM



2022-12-21

جودة الإصدار: تاريخ الإصدار

.....

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للاحتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والأرامل" وكذلك قانون 99 سنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 "الأطفال دون السن الدراسية" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة وطبقا لقاعدة البيانات المرسل من التأمينات الاجتماعية وطبقا لقاعدة البيانات المرسل من الضمان الاجتماعي والبحث تبين أن

السيد (ة) فاطمة اسماعيل احمد بطاقة رقم 25210122700681 وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع يعتبر من الفئات غير المنتفعة بالتأمين الصحي وشكرا

تاريخ الطباعة: 2022-12-21



مسلسل 273274



يعتبر هذا الخطاب ساري لمدة شهر من تاريخ الاصدار

الادارة مركزية لتكنولوجيا المعلومات ودعم القرار

**Kasr El-Ainy Center of Radiation Oncology and
Nuclear Medicine**

Faculty Of Medicine, Cairo University

"NEMROCK"



مركز قصر العيني

للعلاج الأورام والطب النووي

كلية الطب - جامعة القاهرة

(نمروك)

Nuclear Medicine Unit

Report

Patient Name:	Fatma Ismail Ahmed	Patient Gender:	Female
Patient Code:	Q34619	DATE:	12/19/2022 11:42:29 AM

Tc^{99m} MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY

Clinical history

- A patient presented with history of right breast cancer, presents with bony pains for assessment.

Technique

- Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post IV injection of 740 MBq of the tracer.

Findings

- No abnormal osseous tracer uptake detected that would account for serious osseous lesions.
- Degenerative changes of the spine are noted.
- Osteoarthritic changes of shoulders and knees are seen.

Opinion

- No convincing scintigraphic evidence of serious bone lesions.

Dr. Shrouk Atef

Dr. Mahasen Amin, MD

Exam: CT CHEST WITH CONTRAST
Medical ID: _____

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Findings:

I Chest:-

As compared to the last CT chest dated 4/10/2022:

- Status post right mastectomy showing no sizable operative bed masses or collection.
- Stationary tiny subcentimetric left upper and lower lung lobe partly calcified pulmonary nodule (granulomatous).
- Otherwise no newly developed pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is of average size with homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- The scanned skeleton revealed no definite lytic or sclerotic osseous lesions.



Date : 16/05/2024	Patient Name: Fatma Ismail Ahmed Othman Ismail
Age : 71 Year(s)	Exam : ultrasound ABDOMEN& PELVIS
Pat. ID: 20899	Medical ID: 3705/2022

Name: amal fares saad
Date: 16 May 2024

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION REVEALED:

Liver: -

- average in size (about 14 cm at the right MCL), smooth outline, normal echopattern.
- No intra hepatic biliary radicle dilatation.
- Portal vein is not dilated and patent .

Gall Bladder: -

- Average size , , normal wall thickness, no stones..
- CBD is not dilated.

Spleen: -

- Average size , displaying homogenous echopattern.

Kidneys: -

- Are of normal size , site , well differentiated & with no gross stones or backpressure changes , no solid or cystic lesion.
- Para-aortic and pancreatic area: no gross lesion
- No ascites .

URINARY BLADDER: Normal filling. Normal wall thickness, no stones or diverticulae or solid lesion detected.

Uterus : is average size , normal endometrial line , no focal lesion.
No adenxal mass or cyst.

Opinion:

Normal study.

Signature Dr. Doaa Abdelaziz
16/05/2024 1:30 PM

Ismail	
Exam: X-RAY CHEST	Age: 71 Year(s)
Medical ID: 3705/2022	Pat. ID: 20

Name: fatema ismail
Date : 16 May 2024

Plain X-ray Chest (PA view) revealed:

- Mild hyperinflation of the right lung relative to the left.
- Faint dense well defined shadow seen over the mid zone of the right lung (? Over shadowing from the chest wall), otherwise Clear both costo-phrenic angles.
- Normal cardiac size & configuration.
- No bony chest lesion.

Signature Dr. Doaa Abdelaziz
16/05/2024 1:37 PM



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A-Patient ID:

1- Name : فاطمة اسماعيل احمد عثمان

2-ID number: 25210122700681

Sex:

3- Medical number:

83095322

Male

Patient Age : 70 Y

٢٧.٠
٢.٩٩



Family history

BMI

OVER WT

GROUP

B

Menopausal status

POST

Date of MDT

30-Oct-2022

Phone

01157626856

NRS Score

III

marital status

MARRIED

Co morbidity

☐ REASON OF MDT

POST OPERATIVE

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :

BX:

RT IDC GII WITH
DCIS 9/2022

IHC:

ER:

8/8

PR:

6/8

Her 2 Neu :

+VE BY SISH

Ki67 :

20

T

1C

N

1

M

0

Sonomammography

SM 8/2022

RT BREAST SUSPICIOUS LESION

Recommendations:

POST RT MRM

IDC GII WITH DCIS

+VE LN 1/3 WITH EXTRA CAPSULAR EXTENSION

FREE SKIN

FREE MARGIN

OCASSIONAL LYMPHOVASCULAR EMBOLI

YPT1B YPN1

MDT OUTCOME & PLAN

For adj Taxol weekly x 18 + Herceptin SC x 17 cycles

followed by PORT + AI with herceptin

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY

RADIOLOGY

SURGERY

PATHOLOGY

Psychiatric

Nutrition

about:blank

Handwritten signature and notes at the bottom of the page.

Handwritten signature/initials in Arabic script.

بطاقة تحقيق الشخصية

فاطمة

اسماعيل احمد عثمان اسماعيل

١ ش حسن الحداد

مركز اوسيم - الجيزة

٢٥٢١٠١٢٢٧٠٠٦٨١

JF0436001

٢٠٢٢/٠١ ٢٥٢١٠١٢٢٧٠٠٦٨١

ربة منزل

انتى مسلمة

محمود ابراهيم حمانيه سيد

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/٠١/١٧

١



ERM036721849



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A-Patient ID:

1- Name : فاطمة اسماعيل احمد عثمان

Sex:

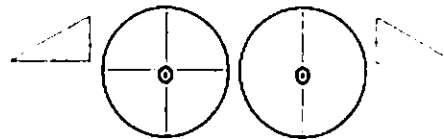
3- Medical number:

83095322

2-ID number: 25210122700681

Male

Patient Age : 70 Y



Family history

Phone

01157626856

BMI

OVER WT

NRS Score

III

GROUP

B

marital status

MARRIED

Menopausal status

POST

Co morbidity

Date of MDT

30-Oct-2022

☐ REASON OF MDT

POST OPERATIVE

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :

BX: RT IDC GII WITH DCIS 9/2022	IHC:	ER: 8/8	PR: 6/8	Her 2 Neu : +VE BY SISH	Ki67 : 20
---------------------------------------	------	------------	------------	----------------------------	--------------

T 1C	N 1	M 0
---------	--------	--------

Sonomammography

SM 8/2022

RT BREAST SUSPICIOUS LESION

Recommendations:

POST RT MRM

IDC GII WITH DCIS

+VE LN 1/3 WITH EXTRA CAPSULAR EXTENSION

FREE SKIN

FREE MARGIN

OCASSIONAL LYMPHOVASCULAR EMBOLI

YPT1B YPN1

MDT OUTCOME & PLAN

For adj Taxol weekly x 18 + Herceptin SC x 17 cycles

followed by PORT + AI with herceptin

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY		RADIOLOGY	
SURGERY		PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	

about:blank



الهيئة العامة للغذاء والدواء
Saudi Food & Drug Authority

الاستشارة
مصر

MDT FORM 24 / 9 / 2022 GB

Name	أحمد محمد	MRN	C.C.C-2700
Age	70 ys.	ID	C.C.C-1000-7M
Menopausal status		Phone	0102222700
NRS SCORE	1+2	marital status	
BMI	over weight	Family history	
Co morbidity	Med. free	REASON OF MDT	

Clinical Data

Bx:	R	L
ER: 8/8	PR: 6/8	HER2: (+2) for IHC
Ki67:		
Sonomammography:	mobile 1cm	v. small Breast
Mets Workup:	Rt cT ⁺ N ⁺ M ⁺	
	fatty breast	

Recommendations:

24/9/2022 → for Bilat Breast u/s + axilla
- IHC
4 ReMDT

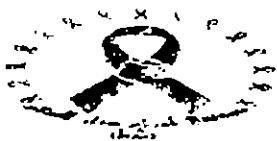
1/10/2022 → Bilat u/s → Rt multicentric (cT⁺c + N⁺)
⊕ intraductal ext.

MDT OUTCOME & PLAN

* For → upfront surgery (considering age, cT⁺c)
Rt mastectomy + ALND

SIGNATURE					
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	psychiatric
أحمد محمد	أحمد محمد			أحمد محمد	

1/10/2022



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A-Patient ID:

1- Name : فاطمة اسماعيل احمد عثمان

2-ID number: 25210122700681

Sex:

3- Medical number:

83095322

Male

Patient Age: 70 Y

Family history

Dx

OVER WT

GROUP

B

Menopausal status

POST

Date of MDT

30-Oct-2022

Phone

01157626856

NRS Score

III

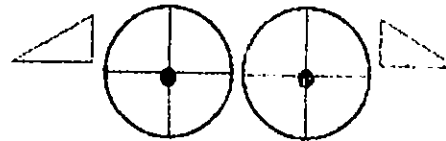
marital status

MARRIED

Co morbidity

☐ REASON OF MDT

POST OPERATIVE



Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :

BX:

RT IDC GII WITH
DCIS 9/2022

IHC:

ER:

8/8

PR:

6/8

Her 2 Neu :

+VE BY SISH

KI67 :

20

T

10

N

1

M

0

Sonomammography

SM 8/2022

RT BREAST SUSPICIOUS LESION

Recommendations:

POST RT MRM

IDC GII WITH DCIS

+VE LN 1/3 WITH EXTRA CAPSULAR EXTENSION

FREE SKIN.

FREE MARGIN

OCASSIONAL LYMPHOVASCULAR EMBOLI

YPT1B YPN1

MDT OUTCOME & PLAN

For adj Taxol weekly x 18 + Herceptin SC x 17 cycles

followed by PORT + AI with herceptin

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY

SURGERY

Psychiatric

RADIOLOGY

PATHOLOGY

Nutrition

- موجات صوتية رباعية الابعاد
- دوبلر ملون قلب - طوعية
- أشعة رقمية (ديجيتال)
- أشعة ثدى - بانوراما

د. بدر حجازي
دكتوراة الاشعة
استشاري الاشعة مستشفى الشرطة بالعجوزة

Patient Name : Fatma Ahmed
Date : 14 August 2022
Prof. Dr. : Amgad Elbogdady

SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY

CRANIO-CAUDAL (FACE) AND OBLIQUE (PROFILE) VIEWS WITH COMPLEMENTRY US

**** RT breast showed a solid mass lesion ,12x6 mm irregular outline ,
of low level echoes and central calcific plaque , located at 9 o'clock
centrally (BI RADS 4)**

**** Normal texture pattern of LT breast showed scattered calcification
with no evidence of abnormal masses or distorted architecture .**

**** Intact nipple and areolar complex with normal skin thickness and
breast contour**

**** Bilateral small axillary non specific lymphadenitis showed
preserved cortico medullary interface and out line oval shaped**

CONCLUSION : RT breast suspicious lesion for further pathology

Best regards

Dr. Badr Hegazy, MD

ACR-BIRADS Classification (Grade 0- Needs further imaging . 1 - Normal . 2- Benign lesion
3- Probably Benign lesion . 4- Probably malignant lesion . 5- Malignant lesion . 6- Pathologically
proved malignant)

RADIODIAGNOSIS CLINIC

١٧ ش السودان - برج الكيت كات ت: ٠١٠٠١٤١٠٧٢٢ - ٠١١٤٠٠٥٠٨٥٠ - ٢٧١٤١٨٠٠ - ٢٣١٤٤٤٧٥
17 El Snudan Str. El Ket Kat Tower, Tel.: 33144475 - 37141800 - 011140050850 - 01001410733



Presidential Program for Women's health

Name: Fatma Ismaeel Ahmed

Date: 24/9/2022

Targeted Bilateral axillary Ultrasound

Clinical summary: right breast pathologically proved IDC

Technique

High resolution ultrasound with Color Doppler.

Detailed Findings

Right breast

- Second look ultrasound showed multicentric malignant looking variable size mass lesions scattered at area between 11-12 o'clock till 1-2 o'clock the largest seen at 11 o'clock measuring 13.3x9mm and the rest (about 3 lesions) are ranging from 8mm to 4mm with suggesting intraductal extension.
- One pathological axillary lymph node measuring 17mm with focal thickened cortex reaching 4.7 mm with eccentric hilum at Level I

Left breast

- No solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- Axillary non-specific nodes.

Conclusion:

Right breast (BIRADS 6) multicentric IDC, with pathological axillary lymph nodes at Level I

Left breast (BIRADS 1)

DR, shaden Mahmoud



Patient Name:	Fatma Ismail Ahmed	Patient Gender:	Female
Patient Code:	Q34619	DATE:	12/19/2022 11:42:29 AM

Tc^{99m} MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY

CAIRO UNIVERSITY - KASR EL-AINY CENTER OF RADIATION ONCOLOGY AND NUCLEAR MEDICINE

Clinical history

- A patient presented with history of right breast cancer, presents with bony pains for assessment.

Technique

- Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post IV injection of 740 MBq of the tracer.

Findings

- No abnormal osseous tracer uptake detected that would account for serious osseous lesions.
- Degenerative changes of the spine are noted.
- Osteoarthritic changes of shoulders and knees are seen.

Opinion

- No convincing scintigraphic evidence of serious bone lesions.

Dr. Shrouk Atef

Dr. Mahasen Amin, MD

Patient Name: Fatma Ismail Ahmed Othman Ismail	Date : 04/01/2023
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 70 Year(s)
Medical ID:	

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Findings:

I Chest:-

As compared to the last CT chest dated 4/10/2022:

- Status post right mastectomy showing no sizable operative bed masses or collection.
- Stationary tiny subcentimetric left upper and lower lung lobe partely calcified pulmonary nodule (granulomatous).
- Otherwise no newly developed pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.

II Abdomen & pe'vis:

- The liver is of average size with homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogenously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- The scanned skeleton reveled no definite lytic or sclerotic osseous lesions.

Patient Name: Fatma Ismail Ahmed Othman Ismail	Date : 04/01/2023
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 70 Year(s)
Medical ID:	

- Reduced vertical height of L4 vertebra.
- Spondylodegenerative changes with L5-S1 bilateral facet arthropathy

Opinion:

- Status post right mastectomy showing no CT evidence of pulmonary, hepatic or osseous metastatic deposits.
- Dr. Ghada H. Khalifa, MSc.

Dr. M. ~~Ghadda~~, M.D.



Patient Name: Fatma Ismail Ahmed Othman Ismail	Date : 26/10/2023
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 71 Year(s)
Medical ID: 3705/2022	Pat. ID: 20899

LEFT BREAST MAMMOGRAPHY WITH BILATERAL US

Indication:

Patient had right MRM

Technique

- Left breast MLO and CC views
- Bilateral ultrasound

Report:

- scattered fibroglandular densities of the left breast (ACR B)
- left breast retro-areolar tubular densities appreciated in CC view, with no spiculated masses or grouped microcalcifications.
- Complementary ultrasound also showed no left breast solid or cystic masses
- Normal skin thickness and nipple-areola complex, with prominent retro-areolar ducts
- Nonspecific left axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free right operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- Free right infra and supra clavicular regions.

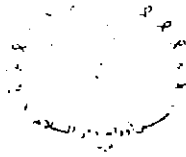
Opinion:

- Right MRM with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- No left breast suspicious findings (BIRADS 2)

Yours truly

Signature Dr. Engy Abdallah

26/10/2023 2:01 PM



Patient Name: Fatma Ismail Ahmed Othman Ismail	Date : 23/05/2024
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 71 Year(s)
Medical ID: 3705/2022	Pat. ID: 20899

Targeted ultrasound on right operative bed

Indication:

- Patient with right MRM with palpable operative bed lesion for assessment.

Report:

- The area of patient complain is consistent to post-operative fibrosis, with no suspicious findings detected (BIRADS 2)
- Free supra and infra clavicular regions.

Signature: Dr. Engy Abdallah

23/05/2024 5:10 PM



Date : 16/05/2024	Patient Name: Fatma Ismail Ahmed Othman Ismail
Age : 71 Year(s)	Exam : ultrasound ABDOMEN& PELVIS
Pat. ID: 20899	Medical ID: 3705/2022

Name: amal fares saad
Date: 16 May 2024

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION REVEALED:

Liver: -

- average in size (about 14 cm at the right MCL), smooth outline, normal echopattern.
No intra hepatic biliary radicle dilatation.
- Portal vein is not dilated and patent .

Gall Bladder: -

- Average size , , normal wall thickness, no stones..
- CBD is not dilated.

Spleen: -

- Average size , displaying homogenous echopattern.

Kidneys: -

- Are of normal size , site , well differentiated & with no gross stones or backpressure changes , no solid or cystic lesion.
- Para-aortic and pancreatic area: no gross lesion
- No ascites .

URINARY BLADDER: Normal filling. Normal wall thickness, no stones or diverticulae or solid lesion detected.

Uterus: is average size , normal endometrial line , no focal lesion.

No adenxal mass or cyst.

Opinion:

Normal study.

Signature Dr. Doaa Abdelaziz
16/05/2024 1:30 PM

Ismail

Exam: X-RAY CHEST

Age: 71 Year

Medical ID: 3705/2022

Pat ID: 20

Name: fatema ismail

Date : 16 May 2024

Plain X-ray Chest (PA view) revealed:

- Mild hyperinflation of the right lung relative to the left
- Faint dense well defined shadow seen over the mid zone of the right lung (? Over shadowing from the chest wall), otherwise Clear both costo-phrenic angles.
- Normal cardiac size & configuration.
- No bony chest lesion.

Signature Dr. Dcaa Abdelaziz

16/05/2024 1:07 PM



Patient Name: Fatma Ismail Ahmed Othman Ismail	Date : 31/10/2024
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 72 Year(s)
Medical ID: 3705/2022	Pat. ID: 20899

RIGHT BREAST MAMMOGRAPHY WITH BILATERAL US

Indication:

Patient have right MRM with right porta Cath

Technique

- Left breast MLO and CC views
- Bilateral ultrasound

Report:

- The left breast is heterogeneously dense which may obscure small lesions (ACR C), scattered fibroglandular densities of the right breast (ACR B)
- No spiculated masses or grouped microcalcifications.
- Complementary ultrasound also showed:
- Left breast 11 o'clock probably benign solid mass lesion measured 10x5mm
- Free right operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- Free right infra and supra clavicular regions.
- Normal skin thickness and nipple-areola complex, with average caliber of the retro-areolar ducts
- Nonspecific left axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.

Opinion:

- Right MRM with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- Left breast 11 o'clock probably benign solid mass lesion suspicious findings (BIRADS 3)

Dr, basma mohmaed

Not Approved



Patient Name: Fatma Ismail Ahmed Othman Ismail	Date : 08/08/2024
Exam : C.T CHEST	Age : 72 Year(s)
Medical ID: 3705/2022	Pat. ID: 20899

Non CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, :-

Findings:

As compared to the last CT chest dated 4/01/2023:

- Status post right mastectomy showing no sizable operative bed masses or collection.
- Still noted subcentimetric bilateral upper and lower lung lobe partely calcified pulmonary
- Still noted mild bilateral upper lobes pleural thickning mounting to pleural tags seen at apical segment of right upper lung lobe
- No newly developed pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.

Opinion :

Rather stationary course since the last study

Dr./Reem Elwaly

Signature Prof. Menna Talla Hanafy

19/08/2024 07:11 م

THE GENERAL ORGANIZATION OF

TEACHING HOSPITALS & INSTITUTES
NATIONAL HEART INSTITUTE
Tel : 3052972 - 3052973 Fax : 3479889



الهيئة العامة للمستشفيات
والمعاهد التعليمية
معهد القلب القومي

ت : ٣٠٥٢٩٧٢ - ٣٠٥٢٩٧٣ فاكس : ٣٤٧٩٨٨٩

Echo Doppler Report

Name: فاطمة اسماعيل احمد	Date: 6 / 9 / 2023
Ref by Prof.: Dr.	Age: 71 Years
Measurement:	
LV EDD 5.0 (3.5 - 5.6 cm)	Left atrium 3.1 (1.9-4.0 cm)
LV ESD 2.9	Aortic root 2.2 (2.0-3.7 cm)
LV SWT 0.8 (0.7 -1.1 cm)	AO. Excursion -- (1.6-2.6 cm)
LV PWT 0.9 (0.7-1.1 cm)	Rt. Ventricle -- (0.7-2.3 cm)
EF 67 %	FS 40 %

Two Dimensional And M-Mode Echo Cardiographic Findings

☐ The Mitral Valve : Normal.

Motion :	Calcification:	Area :
Thickness:	Subvalvular:	Score:
The Aortic Valve	Normal	
The Pulmonic Valve	Normal	
The Tricuspid Valve	Normal	
The Left Ventricle	Normal	
The Segmental Wall	No	
Motion Abnormalities		
The Interventricular Septum	Intact	
The Interatrial Septum	Intact	
Masses	None	
Pericardium	Normal	

☐ Doppler and Color Flow Findings:

	A/E	Max/MN. PG (Diastolic)	Max/MN. PG (Systolic)	Valve area	Regurge/Grade	Jet area
Mitral						
Aortic						
Tricuspid						
Pulmonic						

☐ Conclusions:

- ☐ Normal left ventricular internal dimensions with good left ventricular systolic function .
- ☐ No SWMA at rest.
- ☐ Grade I left ventricular diastolic dysfunction .
- ☐ Mild mitral regurge .
- ☐ Mild tricuspid regurgitation (EPASP $\approx$ 35 mmHg) .

Signature
DR: Ibrahim Mohamed

بسم الله الرحمن الرحيم
(وإذا مرضت فهو يشفين)

Echocardiography Report

Name of the patient	Fatma ismail, 71 yrs		
Referring doctor	Prof Dr.,	Sex	Female
Operator	Dr. Amr Yosry Ibrahim	Date	15 June 2023

Measurements

2D Dimensions

		Normal			Normal
Aortic root diameter	25	20-40 mm	IVS	09	07-11 mm
Left atrium diameter	40	20-40 mm	PW	09	07-11 mm
Aortic cusp separation	16	15-25 mm	LVEDD	53	32-57 mm
			LVESD	28	22-40 mm
			EF	70	52-75%
			FS	40	%

Comments:

- Normal LV internal dimensions, with normal LV systolic function, estimated EF is 70% by M-mode and by 2D eyeballing.
- **Diastolic dysfunction grade I.**
- Normal LV wall thickness.
- No SWMA at rest.
- **Mildly dilated LA dimension** and normal aortic root dimensions.
- **Sclerotic MV morphology with mild central MR,**
- **Sclero-calcific tri-leaflet AV** with no significant systolic gradient.
- Normal TV morphology with **mild to moderate TR**, estimated RVSP= 36 mmHg.
- Normal RV function and dimension (TAPSE=1.7).
- No intracardiac masses or thrombi by TTE.
- Normal pericardium, no pericardial effusion.

• Conclusion:

- *Diastolic dysfunction grade I.*
- *Mild MR, Mildly dilated LA.*
- *Mild to moderate TR with mild pulmonary HTN.*

DR. AMR YOSRY IBRAHIM
MSC CARDIOLOGY



Echo Doppler Report

Name:	فاطمة اسماعيل احمد عثمان اسماعيل	Date:	26 / 7 / 2023
Ref by Prof: Dr.		Age	71 Years
Measurement:			
LV E DD	4.8 (3.5 – 5.6 cm)	Left atrium	3.2 (1.9-4.0 cm)
LV E SD	2.9	Aortic root	2.0 (2.0-3.7 cm)
LV SWT	0.9 (0.7 -1.1 cm)	AO. Excursion	-- (1.6-2.6 cm)
LV PWT	0.9 (0.7-1.1 cm)	Rt. Ventricle	-- (0.7-2.3 cm)
EF	68 %	FS	--

Two Dimensional And M-Mode Echo Cardiographic Findings

The Mitral Valve : Normal

Motion :		Calcification:		Area :	
Thickness:		Subvalvular:		Score:	
The Aortic Valve	Normal				
The Pulmonic Valve	Normal				
The Tricuspid Valve	Normal				
The Left Ventricle	Normal				
The Segmental Wall	No				
Motion Abnormalities					
The Interventricular Septum	Intact				
The Interatrial Septum	Intact				
Masses	No				
Pericardium	Normal				

Doppler and Color Flow Findings:

	A/E	Max/MN. PG (Diastolic)	Max/MN. PG (Systolic)	Valve area	Regurge/Grade	Jet area
Mitral						
Aortic						
Tricuspid						
Pulmonic						

Conclusions:

- Normal left ventricular internal dimensions with good left ventricular systolic function.
- No SWMA at rest.
- Mild mitral regurgitation.
- Mild to moderate tricuspid regurgitation (EPASP $\approx$ 45 mmHg).

Signature

DR: Ibrahim Mohamed

**Echo Doppler Report**

Name: فاطمة اسماعيل احمد	Date: 21 / 10 / 2023
Ref by Prof.: Dr.	Age: 71 Years
Measurement:	
LV E DD 4.8 (3.5 – 5.6 cm)	Left atrium 3.7 (1.9-4.0 cm)
L V E SD 3.2	Aortic root 2 (2.0-3.7 cm)
L V SWT 0.9 (0.7 -1.1 cm)	AO. Excursion --- (1.6-2.6 cm)
L V PWT 0.9 (0.7-1.1 cm)	Rt. Ventricle --- (0.7-2.3 cm)
EF 60%	FS ---

Two Dimensional And M-Mode Echo Cardiographic Findings**The Mitral Valve : Normal**

Motion	Calcification:	Area :
Thickness:	Subvalvular:	Score:
The Aortic Valve	Normal	
The Pulmonic Valve	Normal	
The Tricuspid Valve	Normal	
The Left Ventricle	Normal	
The Segmental Wall	No	
Motion Abnormalities		
The Interventricular Septum	Intact	
The Interatrial Septum	Intact	
Masses	No	
Pericardium	Normal	

Doppler and Color Flow Findings:

	A/E	Max/MN. PG (Diastolic)	Max/MN. PG (Systolic)	Valve area	Regurge/Grade	Jet area
Mitral						
Aortic						
Tricuspid			27 mmHg		Mild regurge	
Pulmonic						

Conclusions:

- Normal echodoppler scanning except for grade II diastolic dysfunction .

Signature

DR: Mary Joseph

Echocardiography

Name : Fatmah Esmail

Date : 06/02/2023

مستشفى الشرق

40 ش الرشيد - مدينة الأوقاف

ت: 33465745

Items	Measures	Normal	Items	Measures	Normal
L.V.E.D.D.	5.2 cm	4.3-5.7	Ao.V.area	2.6 cm	2.9-3.4 cm
L.V.E.S.D	3.4 cm	3.5-3.9	Peak Ao.F.	1.6 m/s	1 m/s
I.V.S.	1.0 mm	0.7-.9	M.V.Area	5.5 cm	3.9-6.5 cm
L.A.D.	3.6 cm	2.6-3.8 cm	Pul.A.Press.	29 mmhg	13-25 mmhg
E. F. %	58 %	55-80%	F.S.	37 %	35-45 %

Normal Lt.V. internal dimensions with trivial apical hypokinesia & diastolic dysfunction grade I. and E.F.= 58 %

Normal Lt.atrial. internal dimensions .

Mild Senile calcifications of Mitral & Aortic Valves with trivial stenoses and no regurge .

Pulmonary and Tricuspid Valves are of normal mobility & flow & pressures and architectures

Normal Pericordium with no effusion.

No Intracardiac Masses or Thrombus .

Conclusions :

A Picture of An mild Ischemic H. D. & Diastolic dysfunction grade I. and mild senile calcifications of Mitral & Aortic Vs. with trivial stenoses .

Cardiologist Dr. Nabila Kamel

THE GENERAL ORGANIZATION OF

TEACHING HOSPITALS & INSTITUTES
NATIONAL HEART INSTITUTE
Tel : 3052972 - 3052973 Fax : 3479889



الهيئة العامة للمستشفيات
والمعاهد التعليمية
معهد القلب القومي

ت : ٣٠٥٢٩٧٢ - ٣٠٥٢٩٧٣ فاكس : ٣٤٧٩٨٨٩

Echo Doppler Report

Name: فاطمة اسماعيل احمد عثمان	Date: 3 / 5 / 2023
Ref by Prof.: Dr.	Age: 71 Years
Measurement:	
L V E DD 4.6 (3.5 - 5.6 cm)	Left atrium 3.3 (1.9-4.0 cm)
L V E SD 3.0	Aortic root 2.2 (2.0-3.7 cm)
L V SWT 1.0 (0.7 -1.1 cm)	AO. Excursion - (1.6-2.6 cm)
L V PWT 0.7 (0.7-1.1 cm)	Rt. Ventricle - (0.7-2.3 cm)
EF 60 %	FS 30 %

Two Dimensional And M-Mode Echo Cardiographic Findings

The Mitral Valve: Normal

Motion :	Calcification:	Area :
Thickness:	Subvalvular:	Score:
The Aortic Valve	Normal	
The Pulmonic Valve	Normal	
The Tricuspid Valve	Normal	
The Left Ventricle	Normal	
The Segmental Wall	No	
Motion Abnormalities		
The Interventricular Septum	Intact	
The Interatrial Septum	Intact	
Masses	No	
Pericardium	Normal	

Doppler and Color Flow Findings:

	A/E	Max/MN. PG (Diastolic)	Max/MN. PG (Systolic)	Valve area	Regurge/Grade	Jet area
Mitral						
Aortic						
Tricuspid						
Pulmonic						

Conclusions:

- Normal left ventricular internal dimensions with good left ventricular systolic function.
- Paradoxical septal wall motion.
- Moderate mitral regurgitation.
- Moderate tricuspid regurgitation (EPASP $\approx$ 40 mmHg).

Signature

Dr. - Ibrahim Mohamed

Echocardiographic Report

Name : Fatma Ismail Ahmed Osman

Date : 03/10/ 2022

Age : 70 Y

M-Mode Measurements

LVEDD : 4.4 cm. (3.7 - 5.6)	FS : 39 % (25 -40%)
	EF : 69 (55-75%)
LVESD : 2.7 cm.	RV : 1.4 cm (0.7 -2.6)
SWT : 0.8 cm. (0.7 - 1.1)	LA : 3.6 cm (< 4.0)
PWT : 0.8 cm. (0.7 - 1.1)	Ao.root : 3.2 cm (< 3.7)

Comments:

- * Normal left ventricular dimensions.
Normal global contractility.
Diastolic dysfunction.
- * Normal left atrium.
- * Normal right atrium and right ventricle.
- * No apparent intracardiac masses or thrombi
- * No pericardial effusion.
- * All valves appear normal.


M. Aziz Madkour, MD.



Patient Name : الأستاذة / فاطمة اسماعيل احمد عثمان اسماعيل
Patient No. : 25210122700681
Path No. : 3008/22
Sex : Female
Age : 69 Y
Referreing Doc :
Request No. : 13009779
Request Date : 11/10/2022
Verification Date : 23/10/2022
Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Department : Out Patient
Registered by : .marwa mohamed youss

Pathology Report

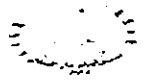
Dr.Samah Sayed

Verified by :
saamah sayed

Printing Date : 25/10/2022 10:03:35

Page 2 of 2

Printing By : Ali mostafa



قرية رقم (4) - القادر / 1 - مباني رقم (987) - مستشفى الطول - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Bldg. No. (4) - First Floor-Building No. 987 - Nile Corralms - Near El Qadous, Cairo,
Egypt

Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab
المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي

Patient Name	: الأستاذة / فاطمة اسماعيل احمد عثمان اسماعيل	Request No.	: 13009779
Patient No.	: 25210122700681	Request Date	: 11/10/2022
Path No.	: 3008/22	Verification Date	: 23/10/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 69 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc	:	Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

Dr.Samah Sayed

Verified by :
saamah sayed

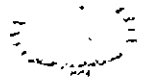
Printing Date : 25/10/2022 10:03:35

Page 2 of 2

Printing By : Ali mostafa



Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab
المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي



Patient Name	: الأستاذة / فاطمة اسماعيل احمد عثمان اسماعيل	Request No.	: 13009779
Patient No.	: 25210122700681	Request Date	: 11/10/2022
Path No.	: 3008/22	Verification Date	: 23/10/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 69 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data : Right breast cancer

Nature of the specimen : Right MRM

Gross Examination:

- Procedure: Right MRM specimen measured 19x18x4 cm , covering skin ellipse measured 15x9 cm .
- Tumor extent : An ill defined greyish white firm mass measured 0.6x0.6 cm .
- Distance from margins: 2 cm away from deep margin .
- Lymph nodes number and size: A fibrofatty tissue piece measured 7x5x2 cm enclosing 9 SLNs up to 1.5 cm .

Microscopic examination:

- Histological type: Invasive duct carcinoma
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1)
- Angioinvasion: Occasional
- Perineural invasion : No
- Ductal carcinoma in situ: Present 5%
- Lymph node involvement: Positive (1/9) without extracapsular extension .
- Resection Margins: Free margins
- Additional pathologic findings: Rest of breast showing mammary ductectasia, florid atypical ductal hyperplasia , apocrine metaplasia .

Diagnosis:

Right MRM :

Invasive duct carcinoma Grade II with DCIS .

- Positive LNs (1/9) without extracapsular extension .
- Free skin , free margins
- Occasional lymphovascular emboli .
- Stage : pT1b , pN1

Prof. Dr. Lubna Omar

Verified by :

saamah sayed

Printing Date : 25/10/2022 10:03:35

Page 1 of 2

Printing By : Ali mostafa

Patient Name : الأستاذة / فاطمة اسماعيل احمد عثمان اسماعيل	Request No. : 13008849
Patient No. : 25210122700681	Request Date : 29/08/2022
Path No. : 2525/22	Verification Date : 14/09/2022
Sex : Female	Financial Category : اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age : 69 Y	Department : Out Patient
Referring Doc. :	IHC No. :
	Registered by : marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Right breast mass lesion

Nature of the specimen:

Tru cut biopsy collected 28-8-2022 (10 :40 AM)

Gross Examination:

Fragmented greyish white tissue cores ranging from 0.2 to 0.7 cm . Totally submitted .

IHC technique: Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR,HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

- * Histological type: Invasive duct carcinoma
- * Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1)
- * Ductal carcinoma in situ: No
- * IPT (Positive control showed appropriate reactivity) :
- * ER: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (Allred score 8/8)
- * PR: Moderate nuclear reaction in 60% of tumor cells (Allred score 6/8)
- * HER2: Weak incomplete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 2+)
- * Ki 67: 20% nuclear reaction of tumor cells

Diagnosis:

Right breast mass lesion , Tru cut biopsy:

Invasive duct carcinoma grade II

- * ER: Positive (score 8/8).
- * PR: Positive (score 6/8).
- * HER2: Equivocal (score 2+) for SISH.
- * Ki67: Positive in 20% of tumor cells.

بإذن فتيحة علف
طالبة

Prof.Dr.Gamal Abdelatty

Dr.Israa Elgendy

Verified by :
saamah sayed

Printing Date : 18/09/2022 10:00:15

Page 1 of 2

Printed By : .marwa mohamed youss

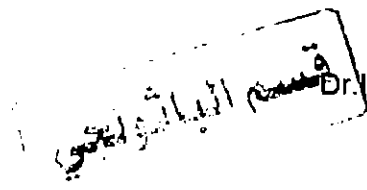


Patient Name	: الأستاذة / فاطمة اسماعيل احمد عثمان اسماعيل	Request No.	: 13008849
Patient No.	: 25210122700681	Request Date	: 29/08/2022
Path No.	: 2525/22	Verification Date	: 28/09/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 69 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

* SISH : Amplified

Prof.Dr.Gamal Abdelatty



Dr. Israa Elgendy

Verified by :
DR. Israa Elgendy



اسم المريض رباعي :

الرقم الطبي الموحد :

labs 30/10/22 Hb: 12.1 TLC: 5.7 PLT: 290 ALT: 21
AST: 24 Creat: 0.7

Doctor's Orders

نوع التغذية :

التشخيص :

التاريخ	الوقت	الأوامر	التوقيع
8/11/22	8:00 AM	Upfront MPM 23/10/22 IDC GII, +ve L.N. (1/9) with ECE max 0.6x0.6cm, PT1bM ER 8/8, LPR 8/8, HER2 +ve by SIH	
		MDT weekly Taxol X 18 weeks + Herceptin X 17 cycles AT + PORT	
		(W1) (P) زوفران (P) أقراص (P) إيسوفين (P) لوبريدين قبل العلاج سواء كسول (P) حمض (P) 300 ملع على 1/2 ساعة (P) في كوتاكلي 300 ملع غسيل وريد موسليم ٧x٢x١ كونتروليك ٧x١x١	
		د. ياسر الحنف 13/11/22	
		W1 Taxol Clph. Hader 13/11	

أ. لابد أن تكون واضحة من الطبيب بالاسم الثلاثي والتاريخ والوقت.



Labs on
(18/12)
OK

W6 (18/12)

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى اورام دار السلام (هرمل)
العيادة الإكلينيكية

**Paclitaxel Weekly (weeks ...4... & ...5... & 6.....) +
Trastuzumab Q 3 weeks**

التاريخ: 2021/12/18		اليوم:	
رقم الملف: ٣٧٠٥/٢٢٢٢		اسم المريض: محمد أحمد	
Weight: 80 kg	Height: 165 cm	BSA: 1.79 M2	Age: years
CBC:	WBC: ANC: Hgb: PLT:		
Functions Tests:	Sr.Creat: Urea: CrCL:		
	ALT: AST: T.Bil: D.Bil:		
Echo:	Date: EF: %		
Dose Modification: %			
Reason: ☐ Hematological ☐ Non hematological:			
امضاء التمريض	بروتوكول العلاج		الصراف
الاسبوع:	جرانيسيتون (0.01 مجم/كجم) مجم + ديكساميثازون 20 مجم + انتودين 20 مجم + امبول افيل) في 50 مل ج 5% علي مدي ربع ساعة قبل العلاج الكيماوي. (Maximum dose of Granisetron = 1mg)	الاسبوع W4 بتاريخ 12/12/21	
الاسبوع:		الاسبوع W5 بتاريخ / /	
الاسبوع:	باكليتاكسل (80 مجم/2م) 1.6 كجم في 250 مل ج 5% علي مدي ساعة.	الاسبوع W6 بتاريخ 18/12/21	
	50 مل ج/ملح علي مدي 10 دقائق		
	تراستوزوماب 600 مجم تحت الجلد لمدة 5 دقائق في الفخذ.	يعطي بتاريخ / /	
كوندرولولوك قرص 40 مجم علي الريق يوميا ١٤ x ١ x ١ باراول ١٤ x ٢ سيسا ٧ x ٢ x ١			العلاج التدايمي:
Physician Signature:	Clinical pharmacy:	Dispensing pharmacy:	
W 4 > Taxol 400mg	W 5 > Taxol Cl.ph/Abeer 11/12/2021		
W 6 > Taxol, Aya Fagez, 18/12/2022	Trastuzumab > Date		



إسم المريض رباعي:

الرقم الطبي الموحد:

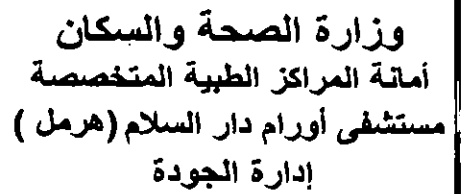
Doctor's Orders

نوع التغذية:

التشخيص:

التاريخ	الوقت	الأوامر	التوقيع
	W4 + 5	تناول ٢٢٦ Bone scan - open 11/12/2022	
	W6	تناول ٢٢٦ epistaxis - 18.12.2022	

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة من الطبيب بالاسم الثلاثي والتاريخ والوقت



الرقم الطبي الموحد :

Doctor's Orders **اوامر الطبيب**

نوع التغذية :

التشخيص:

التاريخ	الوقت	الأوامر	التوقيع
		Bone Scan → Free waiting c/o - wild epstein HP. for myoga se 11/5	

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة من الطبيب بالاسم الثلاثي والتاريخ والوقت



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى اورام دار السلام (هرمل)
الصيدلة الإكلينيكية

Paclitaxel Weekly (weeks7.... &8.... &) +

Trastuzumab + Pertuzumab Q 3 weeks (cycle)

التاريخ: 2021/11/10		اليوم: من	
رقم الملف:		اسم المريض: فاطمة محمد أحمد	
Weight: kg	Height: cm	BSA: M2	Age: years
CBC:	WBC: ANC: Hgb: PLT:		
Functions Tests:	Sr.Creat: Urea: ALT: AST: T.Bil: D.Bil:		
Echo:	Date: EF: 64% 30/10		
Dose Modification: %			
Reason: ☐ Hematological ☐ Non hematological:			
امضاء التمريض	بروتوكول العلاج		الصرف
الاسبوع:	جرانيسترون (0.01 مجم/كجم) مجم + ديكساميثازون 20 مجم + انتودين 20 مجم + امبول افيل في 50 مل ج 5% علي مدي ربع ساعة قبل العلاج الكيمائي.	الاسبوع 7 بتاريخ 2021/11/10	
الاسبوع:	(Maximum dose of Granisetron = 1mg)	الاسبوع 8 بتاريخ 2021/11/11	
الاسبوع:	باكليتاكسل (80 مجم/2م) كجم في 250 مل ج 5% علي مدي ساعة.	الاسبوع بتاريخ / /	
	تراستوزوماب 600 مجم تحت الجلد لمدة 5 دقائق في الفخذ.	يعطي بتاريخ 2021/11/10	
	بروتوزوماب 840 مجم في 250 مل ملح علي مدي 1/2 ساعة (علي مدي ساعة في الجرعة الاولى) Loading Dose: 840 mg Maintenance Dose: 420 mg	1st HP Pending upon approval	
العلاج التديمي:		كونترولوك قرص 40 مجم علي الريق يوميا.	
19 x 1 x 1 12 x 2 x 1		19 x 1 x 1 12 x 2 x 1	
Physician Signature: ~	Clinical pharmacy:	Dispensing pharmacy:	
	W. 7 >> Doaa B T/C HP (ED) 25/12/2022 W. 8 >> Taaol Cl.ph IAbcar 1/1/2023 W. >>	W. >>	
Trastuzumab > Date			



اسم المريض رباعي: محمد عبد الله
الرقم الطبي الموحد:

Doctor's Orders

التشخيص: نوع التغذية: بعد الوجبة

التاريخ	الوقت	الأوامر	التوقيع
10/11/2023		Week 9 Week 10 Week 11 أرجس ٢.٠ X ١ X ١ موتيليم ٢.٠ X ١ X ١ 8/11/2023 ECHO EF 58% for Cardio follow up. Postpone Herceptin W10 Taxol only 10/11/2023 Ph / AHMED	
17/11/2023		W10 Taxol + C1 Herceptin d.ph Ayman 17/11	

جميع الأوامر الطبية يجب أن تكون واضحة من الطبيب بالاسم الثلاثي والتاريخ والوقت

الرقم الطبى الموحد :

→ PT has heart problem as discuss with relative recommend by Cardiology Echo/1st month

التصنيف: نوع التغذية:

التاريخ	الوقت	الأوامر	التوقيع
31/1/2023	(10:00 - 11:00)	⑤ Cycle Week 13 + *** Week 14 Week 15 ارمين V.X.I.X.I موسليم V.X.I.X.I لايكوز شارب ⑥ w.a.2 Taxd CLPh Sunnr C.S.I.I.I.I.I	31/1/2023 Handwritten signature

الرقم الطبى الموحد :



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام (هرمل)
إدارة الجودة

Postment ^{مستقر} RY Brest
RY HRM on 11/10/2022

Doctor's Orders **اوامر الطبيب**

 ~~$T_1 (0.6 \times 0.6), N_1 \frac{1}{6}, H_3$~~

نوع التغذية :-

التشخيص:

ER to 3/2, PR to 5/2, IR 2.24

[illegible]

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة من الطبيب بالاسم الثلاثي والتاريخ والوقت

need echo every 45 days, last echo 6/2/2023

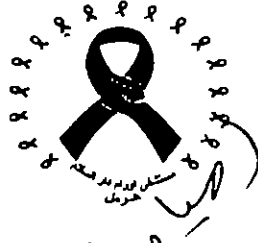
Page 1 of 1

Issue No/Review No: 01/00

Issue date/Review date: 2/2021

F-SMC-MR-G-PH-016 (1012)

So need new echo 20/3/2023



اسم المريض رباعي :
الرقم الطبي الموحد :

Doctor's Orders

نوع التغذية :

التشخيص :

التاريخ	الوقت	الأوامر	التوقيع
2018/12/21		تأكل كول for Dose reduction due to se PN G II for cytarabine ملاحظة خارجية علاوة به راجع السرعة 1.8 تأكل كول السرعة 1.8 تأكل كول	Ph/Aya Dicu Wt 70kg 7/3/2023

New Ch
2018/12/21
↑
21/2
EF 58% 6/2/2023
Age 70
wt 80
Ht 145
BSA 1.79
Wt 80kg
Ht 145cm
BSA 1.79m²
CPR 100%
CPR 100%

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة من الطبيب بالاسم الثلاثي والتاريخ والوقت



٢٠٢١ - ٢٠٢٢

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى اورام دار السلام (هرمل)
العيادة الإكلينيكية

**Paclitaxel Weekly (weeks & &) +
Trastuzumab Q 3 weeks**

اليوم:		التاريخ: ١٤ / ٢ / ٢٠٢١	
اسم المريض: فاطمة حسن		رقم الملف:	
Weight: kg	Height: cm	BSA: M2	Age: years
CBC:	WBC: ANC: Hgb: PLT:		
Functions Tests:	Sr.Creat: Urea: CrCL:		
	ALT: AST: T.Bil: D.Bil:		
Echo:	Date: EF: %		
Dose Modification: %			
Reason: ☐ Hematological ☐ Non hematological:			
الصرف	بروتوكول العلاج		
الاسبوع (١٦)	جرانيسون (0.01 مجم/كجم) مجم + ديكساميثازون 20 مجم + انتودين 20 مجم + امبول افيل في 50 مل ج 5% علي مدي ربع ساعة قبل العلاج الكيماوي.		
الاسبوع	(Maximum dose of Granisetron = 1mg)		
الاسبوع	باكليتاكسل (80 مجم/2م) مجم في 250 مل ج 5% علي مدي ساعة.		
الاسبوع	50 مل ج/مل علي مدي 10 دقائق		
يعطي بتاريخ	تراستوزوماب 600 مجم تحت الجلد لمدة 5 دقائق في الفخذ.		
العلاج التدايمي:	كونترولوك قرص 40 مجم علي مدي يومين.		
Physician Signature: <i>Ha Al-Sayid</i> Clinical pharmacy: W. Al-Sayid Ph/Aya Niam 14/2/2022 Dispensing pharmacy: 14/2/2022 Trastuzumab > Date			

فاطمة اسماعيل أحمد عتار
اسم المريض رباعي :
الرقم الطبي الموحد : ٣٦٠٥/٥٤٤



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام (هرمل)

إدارة الجودة
تعداد الإيكو كل
جرعتين

Echo 18/3 → 54/1

Doctor's Orders الأوامر الطبيب

التشخيص: نوع التغذية:

التاريخ	الوقت	الأوامر	التوقيع
54/1	18/3	C.H. Herceptin 600 S.C. Femara 1x1x90 Capecitabine 1x1x90 oneupla 1x1x90 Cym.Batex 30 → 1x2x90	عند جراحة ١٤/٣/٢٠٢٣
		ph/Aya Dica 21/3/2023 Har C.	
		C5 Herceptin 600 S.C. Femara 1x1x90 Capecitabine 1x1x90 oneupla 1x1x90	فكرت ١٤/٣/٢٠٢٣
		ph/Aya FayeZ C5 (H) S.C. 11/4/2023	١٤/٣/٢٠٢٣ مستشار البريق ١٤/٣/٢٠٢٣
		صيدلية خارجي	

مستشار الإيكو
قبل الجرعة
القادمة

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة من الطبيب بالاسم الثلاثي والتاريخ والوقت

Handwritten signature

اسم المريض رباعي:

الرقم الطبي الموحد:



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أوران دار السلام (هرمل)
إدارة الجودة

Handwritten signature

Doctor's Orders

أوامر الطبيب

نوع التغذية:

التشخيص:

التاريخ	الوقت	الأوامر	التوقيع
27/5/2023	15:00	Handwritten medical orders in Arabic and English, including 'Pt encephalopathy', 'cl. ph. Aya', and 'cl. ph. Daga Boudy'.	Handwritten signature

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة من الطبيب بالاسم الثلاثي والتاريخ والوقت

27/5/2023

Page 1 of 1

لرقم الطبى الموحد :

نوع التغذية:

التشخيص:

[illegible]

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة من الطبيب بالاسم الثلاثي والتاريخ والوقت

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام (هرمل)
إدارة الجودة



إسم المريض رباعي :

الرقم للطبي الموحد :

Doctor's Orders **اوامر الطبيب**

التشخيص:

نوع التغذية:

[illegible]

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة من الطبيب بالاسم الثلاثي والتاريخ والوقت



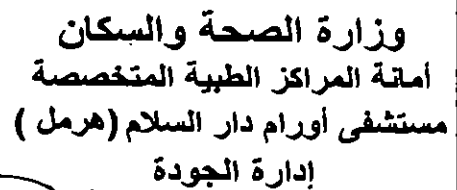
اسم المريض رباعي: فاخره محمد احمد
الرقم الطبي الموحد: ٢٧٠٥ / ٢٠٢٢

اوامر الطبيب Doctor's Orders

التشخيص: نوع التغذية:

التاريخ	الوقت	الأوامر	التوقيع
	C11	Hercept SC SC ن/أسماء محمد C. ٢٢/٨/٢٠٢٠ كل يوم مع حقنة يومية ليداء اسبوع بروتينية شرب واحد ليداء يومية ليداء شرب كل يوم مع حقنة يومية ليداء شهر فسياراً مع حقنة يومية ليداء شهر هرم سميعة مع حقنة يومية ليداء الجلب	Ch. Skin مرحباً بالمرحوب C. ٢٢/٨/٢٠٢٠

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة من الطبيب بالاسم الثلاثي والتاريخ والوقت



الرقم الطبي الموحد :

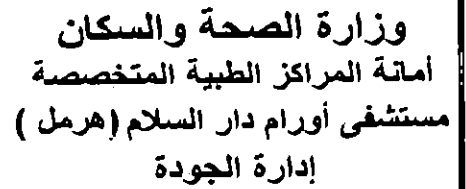
[Echo 69 $\rightarrow$ EF $\rightarrow$ 67%]

نوع التغذية:

التَّشْطِيفُ:

[illegible]

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة من الطبيب بالإسم اللاتيني والتاريخ والوقت



الرقم الطبى الموحد :

+ 62 **Doctor's Orders** **اوامر الطبيب**

نوع التغذية :-

التشخيص:

Capt Herception
 10/1/88
 10/1/88

Page 1 of 1

اسم المريض رباعي: فايزة اسماعيل
 الرقم الطبي الموحد: ٢٧٠١٢٢



وزارة الصحة والسكان
 أمانة المراكز الطبية المتخصصة
 مستشفى أورام دار السلام (هرمل)
 إدارة الجودة

[Echo: EF: 60% ⇒ 21/10/2023]

Doctor's Orders

التشخيص:
 نوع التغذية:

التاريخ	الوقت	الأوامر	التوقيع
12/11/2023	5C	C15 Herceptin 600 mg - femara - Calcimale - Bone Care - Miloga	
		C15 Herceptin 11/12	
		C16 11/12	

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة من الطبيب بأهم الثلاثي والتاريخ والوقت

C16 Herceptin
 11/12

نامہ ایس ایس

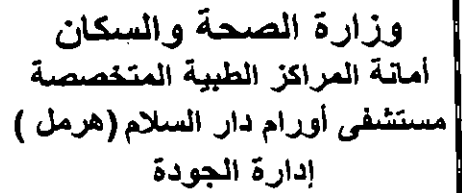
c. 19/20.0

Doctor's Orders اوامر الطبيب

التشخيص:

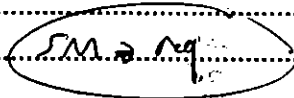
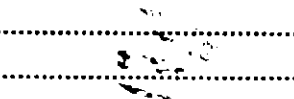
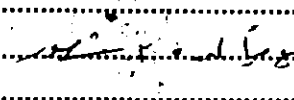
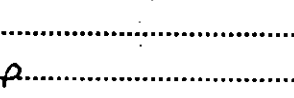
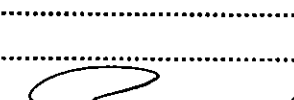
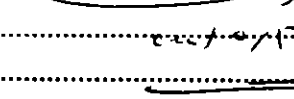
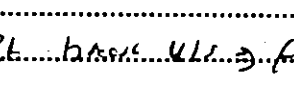
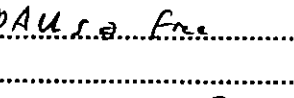
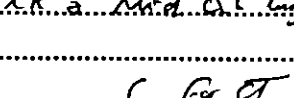
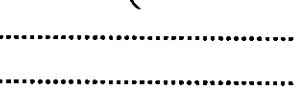
التاريخ	الوقت	الأوامر	التوقيع
١٤٤٤/١٢/٢٤	١٢:٠٠	١- تمديد سيرة ٢- تعيين ٣- كالتج ٤- بورد	١- التوقيع ٢- التوقيع ٣- التوقيع ٤- التوقيع

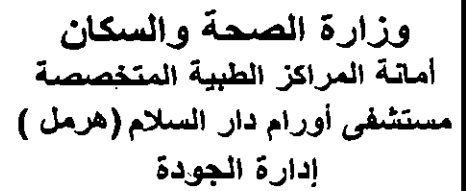
جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة من الطبيب بالاسم الثلاثي والتاريخ والوقت



الرقم الطبى الموحد :

نوع التغذية :

التاريخ	الوقت	الأوامر	التوقيع
		         	

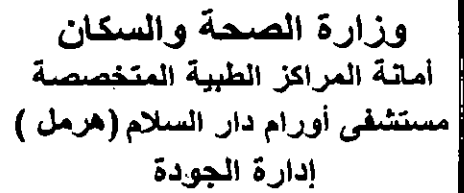


الرقم الطبي الموحد :

نوع التغذية :-

التشخيص:

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة من الطبيب بالاسم الثلاثي والتاريخ والوقت



الرقم الطبى الموحد :

نوع التغذية :

التَّخْصِصُ:

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة من الطبيب بالاسم الثلاثي والتاريخ والوقت

اسم المريض رباعي : قاسم كمال

الرقم الطبي الموحد :



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام (هرمل)
إدارة الجودة

Doctor's Orders **اوامر الطبيب**

نوع التغذية:

التشخيص:

التاريخ	الوقت	الأوامر	التوقيع
		خيارا كالسيوم نيوروفيت جاستين نيادول سالفاس 3m(R)	التوقيع
		خيارا كالسيوم وان الفا نيوروفيت جاستين سبينا دول سلفا اورتو جلون	التوقيع

مع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة من الطبيب بالاسم الثلاثي والتاريخ والوقت